

1

肺癌

非小細胞肺癌を中心とした薬物療法と副作用対応

1 主な治療レジメン・使用薬剤

細胞障害性抗がん薬

シスプラチン+ペメトレキセド(非扁平上皮)、カルボプラチン+パクリタキセル等のプラチナ製剤併用療法

分子標的薬 (ドライバー遺伝子陽性)

EGFR変異:オシメルチニブ等、ALK融合:アレクチニブ等。ROS1・KRAS等にも個別薬剤がある

免疫チェックポイント阻害薬

ペムブロリズマブ、ニボルマブ等。PD-L1発現やドライバー遺伝子陰性例で選択される

血管新生阻害薬併用

ベバシズマブを化学療法・免疫療法と併用することがある

2 肺癌治療で特に注意すべき副作用



間質性肺疾患(ILD):EGFR-TKI・ICI・一部の細胞障害性抗がん薬に共通のリスク。乾性咳嗽・呼吸困難に注意



ICI関連心筋炎:頻度は低いが致死率が高く、動悸・倦怠感の訴えに注意



血管新生阻害薬併用時:高血圧・出血・血栓塞栓症



骨髄抑制:プラチナ製剤併用レジメンで高頻度

3 バイオマーカー検査と薬剤選択

- ☐ 治療開始前にEGFR、ALK、ROS1、KRAS、PD-L1発現等の検査結果を確認する
- ☐ ドライバー遺伝子変異陽性例では、該当する分子標的薬が第一選択となることが多い
- ☐ PD-L1高発現例では免疫チェックポイント阻害薬単独療法が選択されることもある
- ☐ 治療経過中に耐性変異が出現することがあり、再生検・リキッドバイオプシーが検討される

肺癌の薬物療法は、バイオマーカー検査の結果によって治療方針が大きく分かれる「個別化医療」の代表例。検査結果と処方との整合性を意識することが重要。

がん薬物療法 研修シリーズ — 癌種別ガイド 肺癌 — NCCN Guidelines Non-Small Cell Lung Cancer、CTCAE v5.0に基づく